REFERENCES

1. Cruz MC, Camargo RP, Cruz LC, Schiefelbein N, Cruz DM, Cruz MCC. Migrânea: revisão de literatura. Arch Health Invest. 2021;10(2):307-14. doi: [10.21270/archi.v10i2.4670](https://doi.org/10.21270/archi.v10i2.4670.

2. Santos MA, Tolentino G, Pinheiro C, Dach F, Bevilaqua-Grossi D. Perfil de comorbidades associadas à migrânea em crianças e adolescentes de um serviço terciário. Headache Med. 2020;11(Suppl):31. doi: 10.48208/HeadacheMed.2020.Supplement.31.

3. Romualdo de França AV, Barros Madruga T, de Oliveira e Silva V, Viana Barroso LK. Identificação das relações de causalidade entre migrânea e distúrbios cerebrovasculares: uma revisão integrativa. Brazilian Medical Students.2023;8(11). doi: 10.53843/bms.v8i11.322.

4. Comitê de Classificação das Cefaleias da Sociedade Internacional de Cefaleia. Classificação e critérios diagnósticos das cefaleias, nevralgias cranianas e dor facial. São Paulo: Lemos Editorial; 1997.

5. Parreira E, Luzeiro I, Pereira Monteiro JM. Chronic and refractory migraine: how to diagnose and treat. Acta Med Port. 2020;33(11):753-60. doi: 10.20344/amp.12004.

6. Pinto MPC, Melges FM, Caldas PVD, Silva AEC, Meneghette RL. Enxaqueca: revisão literária. Braz J Health Rev.2024;7(3):e70456. doi: 10.34119/bjhrv7n3-359.

7. Tfelt-Hansen P. Naratriptan is as effective as sumatriptan for the treatment of migraine attacks when used properly: a mini-review. Cephalalgia. 2021;41(14):1499-505. doi: 10.1177/03331024211028959.

8. Tfelt-Hansen P. Parenteral vs. oral sumatriptan and naratriptan: plasma levels and efficacy in migraine. A comment. J Headache Pain. 2007;8(5):273-6. doi: 10.1007/s10194-007-0411-x.

9. Maas HJ, Danhof M, Della Pasqua O. A model-based approach to treatment comparison in acute migraine. Br J Clin Pharmacol. 2006;62(5):591-600. doi: 10.1111/j.1365-2125.2006.02670.x.